

Conduite à tenir devant une hémorragie digestive

Dr Mamadou Cissé

Professeur Titulaire

Chirurgie Générale, Module Digestif, 2016-2017

Objectifs

- **Définir** les termes suivants: hémorragie digestive (HD) haute, HD basse, hématomèse, rectorragie, méléna
- **Évaluer** la gravité d'une hémorragie digestive
- **Énumérer** 7 mesures d'urgence à prendre devant une HD
- **Décrire** les conditions de réalisation de l'endoscopie devant une HD haute ou basse
-
- **Citer** 8 étiologies d'HD haute et 8 étiologies d'HD basse
- Décrire la CAT thérapeutique devant une HD d'origine ulcéreuse et une HD par rupture de varices œsophagiennes sur HTP

Introduction

- **Urgence** diagnostique et thérapeutique
- **Endoscopie**: intérêt diagnostique et thérapeutique
- **2 principales étiologies**: ulcère et hypertension portale (HTP)
- **Pronostic**:
 - Arrêt spontané dans 75% des cas
 - Choc hémorragique

Définitions

- On appelle hémorragie digestive un saignement à un point quelconque du tube digestif (de la bouche œsophagienne au canal anal).
- L'hémorragie digestive est dite **haute** si elle provient du tube digestif situé en amont de l'angle duodéno-jéjunal.
- L'hémorragie digestive est dite **basse** quand elle survient en aval de l'angle duodéno-jéjunal.

Définitions

- **Hématémèse**: rejet par la bouche, au cours d'un effort de vomissement de sang rouge ou sombre, provenant de la partie du tube digestif situé en amont de l'angle duodéno-jéjunal.
 - Prodromes: pâleur, lipothymie, vertiges, malaise général, nausées, sensation de plénitude gastrique, de chaleur épigastrique
 - Parfois, elles surviennent brutalement sans prodromes
 - Le volume de sang est variable.
 - Il s'agit de sang sombre, **NON AERE**, mêlé à des caillots et parfois à du liquide gastrique

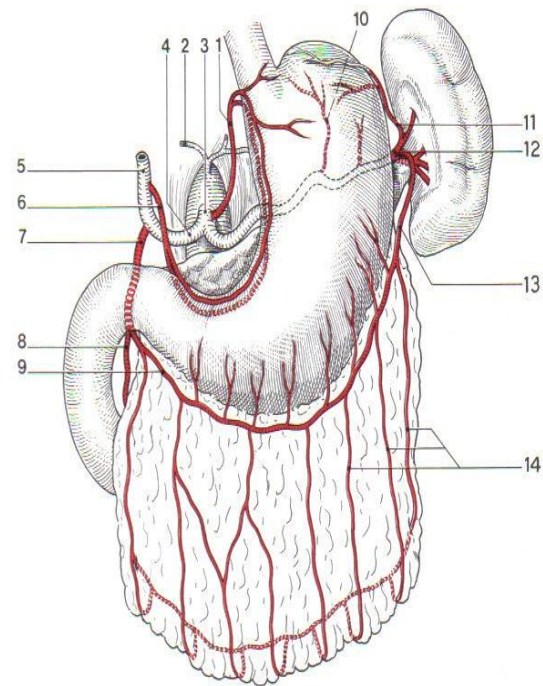
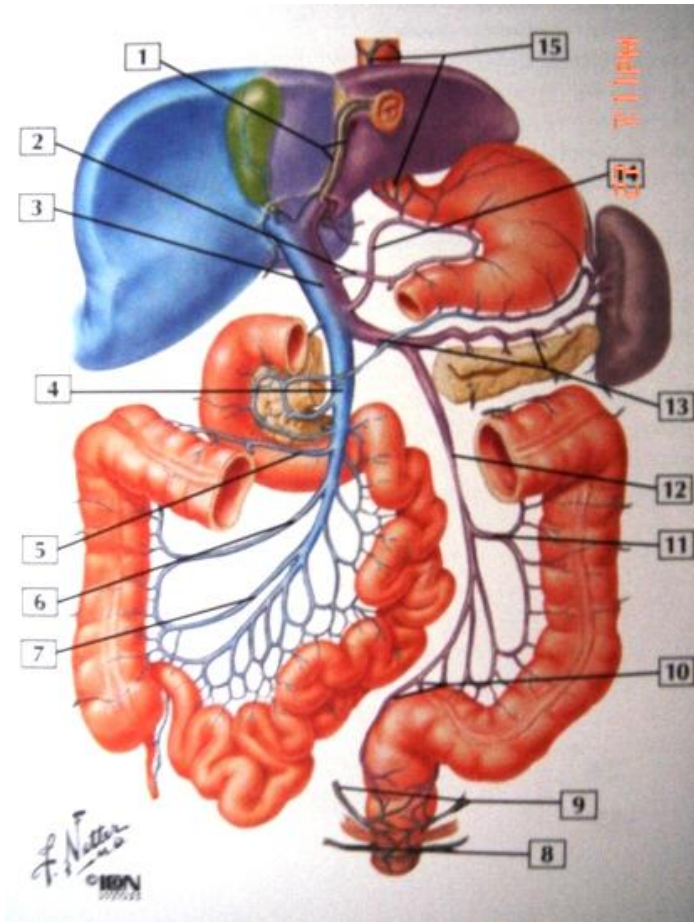
Définitions

- **Méléna:** c'est l'émission par l'anus de sang noir, digéré, mélangé ou non à du sang, isolé ou faisant suite à une hématomèse.
 - **Prodromes:** pâleur, lipothymie, vertiges, sensation de chaleur abdominale
 - Émission de sang fétide, poisseux, gluant et collant, ressemblant à du goudron liquide, de volume variable.

Définitions

- **Rectorragie (Hématochésie):** émission par l'anus de sang rouge.
 - Peuvent faire suite à une hémorragie gastroduodénale massive
(Témoignent d'une hémorragie massive)
 - Origine intestinale ou proctologique

Anatomie

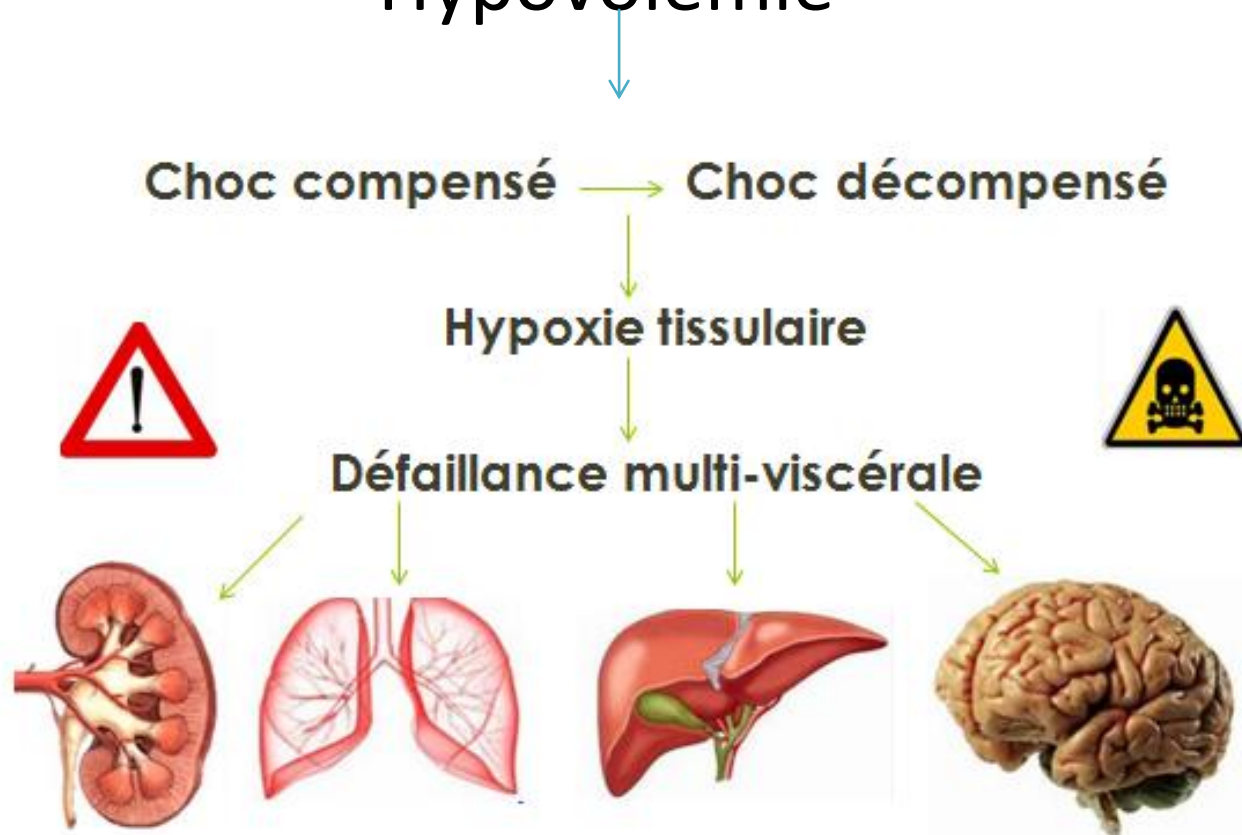


- 1 - A. gastrique gauche
- 2 - A. phrénique inférieure
- 3 - Tronc cœliaque
- 4 - A. hépatique commune
- 5 - A. hépatique propre
- 6 - A. gastrique droite
- 7 - A. gastro-duodénale
- 8 - A. pancréatico-duodénale supéro-antérieure
- 9 - A. gastro-omental droite
- 10 - A. gastrique post.
- 11 - A. courte de l'estomac
- 12 - A. lienale
- 13 - A. gastro-omental gauche
- 14 - Rameaux omentaux

Physiopathologie

Hémorragie digestive

Hypovolémie



CAT diagnostique

- **Diagnostic positif**

- **Circonstances de découverte**

- **Signes évidents:** Hématémèse-Méléna-Rectorragie
 - **Signes d'hémorragie non extériorisée:** malaise, pâleur, ...
 - **Complications:** choc hémorragique, DMV
 - **Hémorragie occulte:** anémie ferriprive

CAT diagnostique

- **Diagnostic positif**
 - **L'interrogatoire et examen clinique complet**
 - **Le toucher rectal**: doigtier souillé de sang
 - Une **sonde naso-gastrique** ramenant du sang



CAT diagnostique

Diagnostic différentiel

- **Devant l'hématémèse**

- Hémoptysie: sang aéré , effort de toux
- Épistaxis
- Gingivorragie
- Vomissement de « substance rouge »: betterave, vin, bissap

CAT diagnostique

Diagnostic différentiel

- **Hémorragie digestive basse**
 - **Selles noires**: traitement martial (Fer), charbon, ...

CAT diagnostique

Diagnostic de gravité

- **Interrogatoire**

- Malaise?
- Douleur thoracique?
- Pathologie associée?: hépatopathie, cardiopathie, ...

- **Examen clinique**

- **Signes de choc +++:** tachycardie précoce, ...

CAT diagnostique

Diagnostic de gravité

- **Paraclinique**
 - Numération formule sanguine et paquettes (Hémoglobine)
 - Groupage sanguin
 - Bilan hémostase: TP, TCK, fibrinogène
 - Bilan hépatique complet
 - Urée, créatinine, ionogramme
 - ECG systématique

CAT diagnostique

Mesures d'urgences

- Pose de 2 voies périphériques de bon calibre
- Remplissage: soluté , transfusion iso groupe iso rhésus
- Monitoring cardio-tensionnel
- Oxygénothérapie
- Pose d'une sonde naso-gastrique (3 objectifs)
- Inhibiteur pompe à protons

CAT diagnostique

Diagnostic étiologique

Enquête étiologique

- **Interrogatoire**

- Prise médicamenteuse gastro-toxique?
- Médicaments anticoagulants?
- Terrain pré-disposant?
 - Hépatopathie, diverticulose, alcool-tabagisme, ...

CAT diagnostique

Diagnostic étiologique

- **Enquête étiologique**

- **Examen clinique**

- Signe en rapport avec une pathologie pré-disposante
 - Toucher rectal +++

- **Explorations paracliniques**

- Biologie
 - Endoscopie
 - Imagerie: scanner, artériographie, ...

CAT diagnostique

Diagnostic étiologique

- **Hémorragies digestives hautes**
 - **Endoscopie digestive haute +++**
 - **Conditions de réalisation**
 - Malade stable hémodynamiquement
 - si hémorragie présumée active: en urgence dans les 6 heures
 - si troubles de la conscience: sous intubation trachéale et sédation
 - Vidange gastrique: érythromycine 250 mg en IV, 30 mn avant
 - **Intérêt:** diagnostic-pronostic-thérapeutique

CAT diagnostique

Diagnostic étiologique

- **Hémorragies digestives hautes**
 - Ulcère gastroduodénal
 - Hypertension portale
 - Œsophagites
 - Syndrome de Mallory-Weiss
 - Tumeurs
 - Ulcère de Dieulafoy,

Diagnostic étiologique

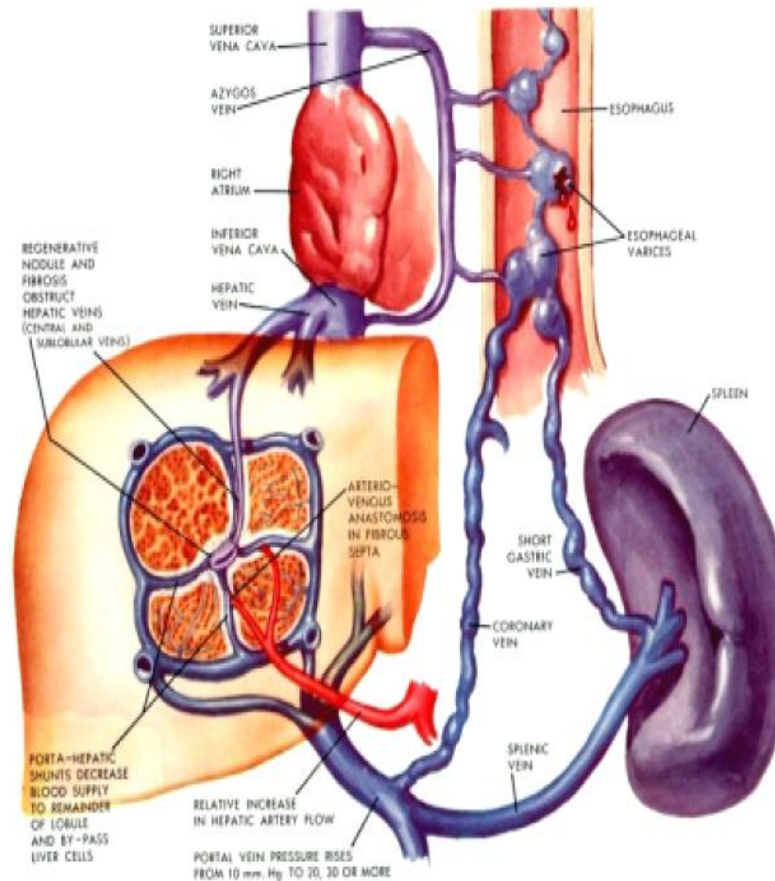
- **Ulcère gastro-duodénal**
 - Arguments en faveur
 - Médicaments gastro-toxiques
 - Maladie ulcéreuse connue
 - Manifestations
 - Hématémèse-rectorragie-méléna
 - Complications

Diagnostic étiologique

- **Ulcère gastro-duodénal**
 - **Endoscopie digestive haute (classification pronostique de Forrest)**
 - **FORREST I:** Saignement actif
 - Fla: jet artériel
 - Flb: suintement
 - **FORREST II:** Signe de saignement récent
 - FIIa: vaisseau visible
 - FIIb: caillot
 - FIIc: tache noire
 - **FORREST III:** Absence de signe de saignement

Diagnostic étiologique

- Hypertension portale sur cirrhose



Diagnostic étiologique

- **Hypertension portale sur cirrhose**
 - **Arguments en faveur**
 - **Cirrhose** : foie dur
 - **Signes HTP**: ascite, circulation veineuse collatérale (syndrome de Cruveilhier-Baumgarten)
 - **Signes d'insuffisance hépatocellulaire**: angiomes stellaires, érythrose palmaire, ...

Diagnostic étiologique

- **Hypertension portale sur cirrhose**
 - **Endoscopie digestive haute**
 - Varices œsophagiennes ; saignement actif ou récent

Diagnostic étiologique

Hémorragie digestive haute

- **Autre étiologies**
 - Œsophagites : peptique, caustique, ...
 - Tumeurs du tube digestif haut

Diagnostic étiologique

Hémorragie digestive haute

- **Autre étiologies**

- **Syndrome de Mallory-Weiss:** déchirure longitudinale de la jonction œsogastrique au décours d'efforts répétés de vomissement.
- **Ulcération de Dieulafoy:** ulcération muqueuse gastrique en regard d'une artère sous muqueuse qui saigne.
- **Wirsungorrhagie:** saignement dans le canal de Wirsung; duodénoscopie à vision latérale. Scanner .
- **Hémobilie:** saignement dans les voies biliaires. Triade de Sanblom

Diagnostic étiologique

- Hémorragie digestive basse
 - Si rectorragie massive avec choc : Endoscopie digestive haute
 - Autres cas: coloscopie totale avec iléoscopie
 - Conditions
 - En urgence dans les 24 heures
 - Sous anesthésie générale
 - Préparation colique complète

Diagnostic étiologique

Hémorragie digestive basse

Étiologies

– Causes coliques

- Diverticulose
- Angiodysplasie
- Tumeurs et polypes
- Colites
-

– Causes proctologiques

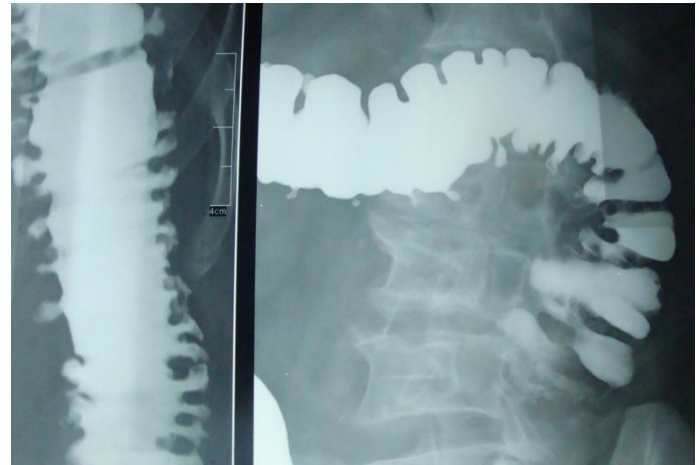
- Hémorroïde
- Fissure
-

• Causes grêliques

- Angiodysplasie
- Maladie de Crohn
- Ulcérations dues aux AINS
- Tumeurs du grêle
- Diverticule de Meckel
-

Diagnostic étiologique

- **Diverticulose colique**
 - Rupture artériole au contact diverticule
 - Arrêt souvent spontané ++
 - Coloscopie
 - Angio scanner



Diagnostic étiologique

- **Angiodysplasie**
 - Dilatations anormales des veines sous muqueuses
 - Sujet âgé +++
 - Siège: côlon droit +++, coecum +++
 - Coloscopie
 - Lésions rondes, rouges, stellaires de quelques mm.

Diagnostic étiologique

- **Tumeurs et polypes**

« Avoir la hantise du cancer »

- **Causes proctologiques**

- Examen ano-rectal
- Coloscopie systématique
- Diagnostic d'élimination



Tumeur colique



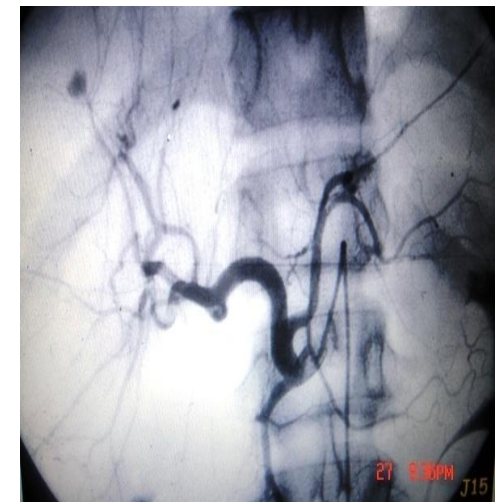
Hémorroïde

Diagnostic étiologique

- Causes grêliques
 - Vidéo-capsule avec entérosopie
 - Scintigraphie au Technétium99m (diverticule de **Meckel**)
 - Artériographie sélective



Diverticule de Meckel



CAT thérapeutique

- **But**

- Préserver le pronostic vital
- Arrêter le saignement
- Supprimer la cause
- Prévenir et traiter les complications

CAT thérapeutique

- **Moyens et méthode**

- **Moyens médicaux**

- **Réanimation**

- 2 voies périphériques de gros calibre: Remplissage vasculaire
 - Transfusion sanguine iso-groupe iso-rhésus
[Objectifs: TAS = 80 mmhg, Hb: 8 g/dl, Ht: 25-30%]
 - Oxygénothérapie
 - Sonde naso-gastrique (lavage à l'eau glacée)
 - Sonde urinaire

CAT thérapeutique

— Moyens médicaux

— Moyens médicamenteux

- **Inhibiteurs de la pompe à proton (IPP):** par voie IV, seringue électrique, bolus de 80 mg puis 8mg/h pendant 3 jours , relais per os.
- **Médicaments vaso-actifs:** octréotide (Sandostatine*): 25ug/h, IV, continue ; Terlipressine (Glypressine*): 1 à 2 mg /4h, IVL
- **Correction troubles hémostasie:** vitamine K, Plasma frais congelé
- **Antibiothérapie préventive:** amoxicilline-ac clavulanique, Norfloxacin: 400mgx2/j pdt 7 jours

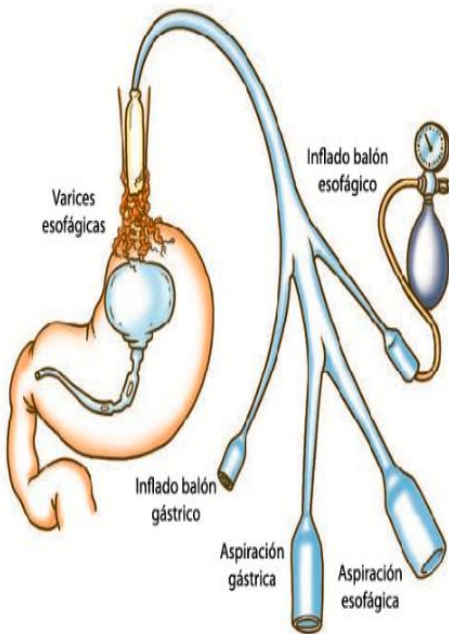
CAT thérapeutique

- **Moyens endoscopiques**
 - **Injections**: sérum adrénaliné dilué, sclérothérapie
 - **Moyens thermiques**: coagulation (plasma argon)
 - **Méthodes mécaniques**: clips, ligatures élastiques
de varices

CAT thérapeutique

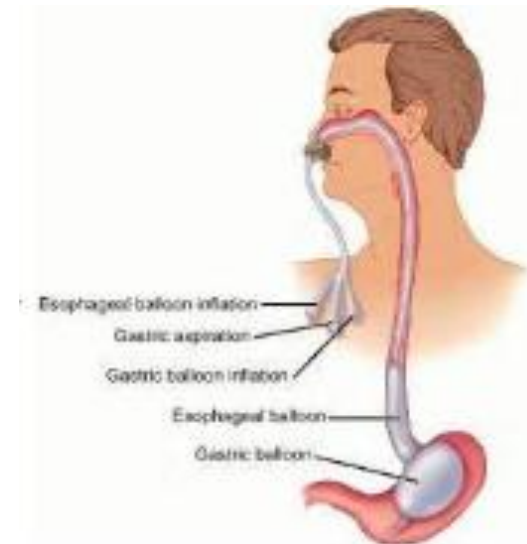
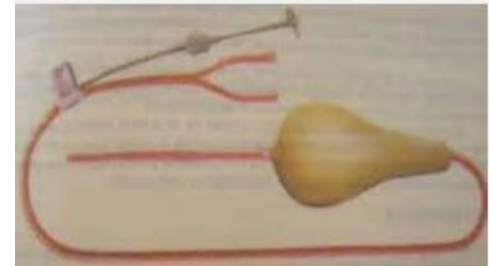
- **Tamponnements mécaniques**

- **Sonde Blakemore**



Ballonnet gastrique: 250 cm³
Ballonnet œsophagien: 60 cm³
1^{er} jour: dégonfler 1h /12h
2^{ème} jour: dégonfler 1h/6h
3^{ème} jour: ablation

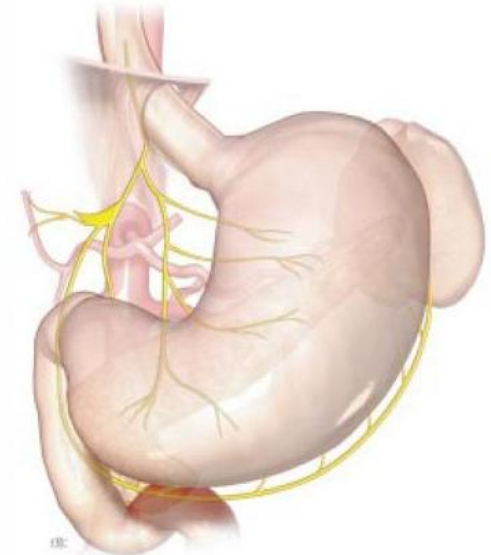
- **Sonde Linton**



CAT thérapeutique

- **Moyens chirurgicaux**

- Antrectomie
- Ligature artère gastro-duodénale
- Gastrotomie + suture hémostatique



8 Pédicule nerveux de la grande courbure gastrique.

- **Dérivations portales** : anastomose porto-caves

CAT thérapeutique

- **Moyens radiologiques**
 - Artériographie + embolisation
 - Dérivation porto sus hépatique par voie trans jugulaire (TIPS)

CAT thérapeutique

Indications

- **Devant toute Hémorragie digestive**

- Hospitalisation
- Réanimation : 4 tuyaux
- Inhibiteur pompe à proton
- Si suspicion HTP: médicaments vaso-actifs



- **En 1^{ère} intention:** Endoscopie diagnostique et hémostatique



- si échec traitement endoscopique : Traitement radiologique ou chirurgical

CAT thérapeutique

Indications

- **Hémorragie digestive d'origine ulcéreuse**

- Réanimation+++

- Lavage eau glacée par sonde naso gastrique

- IPP



- En 1^{ère} intention: Endoscopie hémostatique



- Si échec ou récurrence: 2^{nde} endoscopie hémostatique



- Si échec soit artériographie soit chirurgie

CAT thérapeutique

- **Hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes sur HTTP**

– Réanimation

– IPP + médicaments vaso-actifs

Saignement massif et choc
modéré

Saignement

Sonde de Blakemore

Endoscopie

Echec

Conclusion

- Urgence diagnostique et thérapeutique
- Endoscopie place importante +++
- Causes multiples: HTP et UGD
- Prévention +++